

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMAKAIAN VENTILATOR PADA BAYI		
	No.Dokumen 922.7/I-SPO/NICU/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Oktober 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	Pemberian bantuan napas mekanik pada bayi usia 0-28 hari (prematur maupun cukup bulan) yang mengalami gagal napas atau gangguan pertukaran gas yang berat dengan menggunakan mesin ventilator khusus neonatus		
Tujuan	1. Mempertahankan pertukaran gas yang adekuat dengan konsentrasi oksigen minimal 2. Mencegah kolaps paru (<i>ateletaksis</i>) dengan PEEP yang tepat 3. Meminimalkan kerja otot napas bayi 4. Mengurangi risiko cedera paru pada bayi baru lahir		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 813.1/I-PDM/DIR/IX/2025 Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien		
Prosedur	1. Persiapan Alat dan Mesin a. Sarung tangan steril b. Plester dan Fiksasi c. Suction Catheter d. Pulse Oximetry (SpO2) e. Monitor EKG f. Stetoskop Neonatal g. Self-Inflating Bag (Ambu Bag) / T-Piece Resuscitator (Neopuff) h. WI 1000 ml i. Sduit 10 cc (2) j. Sduit 3 cc (2) k. Obat-obatan sedasi l. Cairan Sukrosa/Glukosa m. Mesin Ventilator : Pastikan memiliki mode khusus neonates n. Sirkuit Ventilator : Gunakan sirkuit neonatus dengan diameter kecil dan memiliki water trap o. Humidifier : Harus menggunakan heated humidifier dengan air steril (suhu diatur sekitar 36.5°C - 37°C). p. Alat Intubasi: 1. Laringoskop dengan bilah lurus (Miller) ukuran 00, 0, atau 1 2. ETT tanpa cuff (ukuran 2.5, 3.0, atau 3.5 sesuai berat badan) 3. Stilet (jika diperlukan) dan plester fiksasi. q. Tes Kalibrasi: Lakukan <i>Pre-use Check</i> dan kalibrasi sirkuit (kompensasi kebocoran dan kepatuhan sirkuit) sebelum disambungkan ke bayi		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMAKAIAN VENTILATOR PADA BAYI		
	No.Dokumen 922.7/I-SPO/NICU/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	2. Langkah-langkah a. Pengecekan Sistem: Nyalakan mesin, lakukan Flow Sensor Calibration dan O2 Calibration. Pastikan tidak ada kebocoran pada sirkuit sekecil apa pun b. Setting Parameter Awal (Sesuai Instruksi Medis) c. Pre-Oksigenasi: Lakukan pemberian oksigen melalui <i>bag-valve-mask</i> (bagging) sebelum prosedur intubasi d. Dokter melakukan pemasangan ETT e. Pastikan posisi ETT benar dengan melihat pengembangan dada simetris, suara napas di kedua lapang paru, dan adanya uap air di ETT f. Lakukan fiksasi ETT ke bibir atas bayi dan catat batas kedalaman (dalam cm) di bibir g. Atur aliran oksigen, sesuai kebutuhan h. Koneksi ke Bayi: Hubungkan sirkuit ke ETT bayi dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi ekstubasi tidak sengaja i. Ekspansi Dada: Amati pergerakan dada; pastikan naik secara simetris namun tidak berlebihan (menghindari pneumotoraks) j. Saturasi Oksigen (SpO2): Target pada bayi prematur biasanya 90–95% (hindari hiperoksia untuk mencegah ROP) k. Lakukan auskultasi di kedua lapang paru dan lambung (memastikan ETT tidak masuk ke esofagus atau bronkus kanan) l. Periksa sirkuit setiap 1-2 jam, buang air yang mengendap agar tidak masuk ke paru bayi m. Lakukan penghisapan lendir (<i>suction</i>) hanya jika ada indikasi (misal: saturasi turun, ada lendir terlihat di ETT) dengan teknik steril dan tekanan rendah (max 60-80 mmHg) n. Berikan sedasi ringan jika bayi tampak "melawan" ventilator (<i>fighting</i>) atas instruksi dokter o. Rapihan pasien dan alat-alat yang digunakan p. Lepaskan sarung tangan q. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah r. Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien		
Unit Terkait	Neonatal Intensive Care Unit (NICU)		